KINESITERAPIA 2

Le bandiere della fisioterapia e il ragionamento etico

Dr. Giacomo Giudici
Fisioterapista
Scienze Motorie

Introduzione

E' responsabilità del Fisioterapista assicurarsi che i propri pazienti siano i candidati giusti per iniziare un percorso di fisioterapia.

→ Al fine di rendere un servizio ottimale dobbiamo essere in grado di determinare quali siano le cause **BIOMECCANICHE** o **NEUROMUSCOLOSCHELETRICHE** che determinano il problema.

→ Il Fisioterapista deve anche essere in grado di riconoscere **i SEGNI e i SINTOMI** di altre problematiche **SISTEMICHE** che possono mimare una causa biomeccanica o neuromuscoloscheletrica.

→ Questo corso serve a dare un aiuto a riconoscere proprio quelle aree di indagine che spesso sono fuori dalle competenze pratiche del Fisioterapista.

Esempi?

→ CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA
→ PNEUMOLOGIA
→ CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA
→ REUMATOLOGIA
→ UROLOGIA E GINECOLOGIA
→ ACCENNI DI PSICHIATRIA
→ ACCENNI SUL PAZIENTE USTIONATO

Introduzione

Qual è il modo migliore per riconoscere segni e sintomi anomali?

L'anamnesi del paziente

Non dimentichiamoci che prima ancora di «mettere le mani» sul paziente è fondamentale spendere tutto il tempo necessario per farci raccontare bene il suo problema e la sua storia (anamnesi prossima e remota).

→ Sintomi
→ Attività abituali e posture
→ Problematiche pregresse e comorbidità
→ Patologie congenite
→ Fumo, alcool, sostanze

Scheda colloquio

Frequenza?

Ma quanto frequentemente può accadere che un segno o un sintomo vadano a mascherare un problema più grave?

Frequenza?

→ Secondo uno studio svolto da Osteopati, **risulta circa l' 1% dei casi**

→ Purtroppo questi non sono dati confermati

→ L'esperienza comune ci dice che questa percentuale **sarebbe molto più alta** se tutti noi eseguissimo degli *screening* di routine su noi stessi e sui nostri pazienti.

Cosa stiamo cercando?

Quali sono i tre fattori chiave che ci possono confondere
e
quindi portano alla necessità di fare screening?

Cosa stiamo cercando?

→ Le comorbidità
→ Gli effetti collaterali dei farmaci
→ I meccanismi viscerali del dolore

(*da Goodman-Schneider – Differential Diagnosis for Physical Therapists*)

Perchè stiamo cercando?

Quali sono i tre motivi per cui eseguiamo uno screening alla ricerca di segni e sintomi viscerali?

Perchè stiamo cercando?

→ L'accesso diretto dei pazienti alle cure
→ Le aree di competenza della fisioterapia si sono ampliate
→ La scoperta e la cura di un problema collaterale sono la chiave per impedire lo sviluppo di comorbidità e complicanze

(*da Goodman-Schneider – Differential Diagnosis for Physical Therapists*)

E se non facciamo nulla?

Se la diagnosi medica viene ritardata, quando sarà possibile ottenere la diagnosi corretta?

E se non facciamo nulla?

→ Il paziente non migliora con nessun intervento fisioterapico
→ Il paziente migliora ma poi peggiora
→ Si sviluppano nuovi segni o sintomi

(*da Goodman-Schneider – Differential Diagnosis for Physical Therapists*)

Quicker and Sicker

Dobbiamo tenere conto del fatto che al giorno d'oggi i pazienti hanno un'età media più alta e vengono curati in Sistemi Sanitari Nazionali che sottostanno a regole economiche molto rigide. Pertanto, gli Americani descrivono questa situazione come «*quicker and sicker*»:

→ QUICKER: al fine di tagliare i costi della sanità, i pazienti vengono **dimessi più rapidamente** rispetto a 10 anni fa.

→ SICKER: con l'aumento dell'età media, è più probabile che un paziente presenti delle **comorbidità**.

Secondo il *National Institute of Ageing*, l'80% degli adulti con età >70 anni hanno almeno una delle **sette patologie croniche invalidanti**: artrite, ipertensione, patologie cardiache, diabete, patologie respiratorie, ictus e cancro.

Un caso

→ Una donna di 44 anni si presenta dal Fisioterapista per dolori paraspinali e del tratto dorsale basso a destra.
→ Nega traumi precedenti o posture scorrette con movimenti ripetuti.
→ La storia clinica riporta soltanto un'infezione renale curata 3 settimane fa. Le ultime analisi delle urine risultano negative, indice della risoluzione dell'infezione.

La valutazione del Fisioterapista rivela una contrattura dei muscoli paravertebrali con una limitazione acuta del movimento e dolore nel tratto D8-D12. La valutazione dimostra inoltre che questa limitazione è data dallo spasmo muscolare e dai *trigger points* e non da un vero blocco articolare.

→ ***CHE COSA FARESTI?***

Un caso

Dopo tre sedute presso lo Studio non è possibile apprezzare alcun miglioramento (né soggettivo, né misurabile).

La paziente chiama per disdire il quarto appuntamento: le è venuta la febbre.

→ ***CHE COSA FARESTI?***

Un caso

Come si poteva immaginare, l'infezione renale non era completamente risolta e ha prodotto una ricaduta.
Anche se questa non è la presentazione più tipica di una problematica infettiva alle vie urinarie, è possibile che l'unico sintomo sia il mal di schiena e che i veri problemi sistemici compaiano dopo alcuni giorni (→ vedi febbre, disuria, ecc…)

Il mal di schiena di questa donna si è risolto spontaneamente dopo 24 ore dalla somministrazione di un nuovo ciclo di antibiotico.

Le bandiere rosse

PRESENTAZIONE CLINICA

→ Eziologia sconosciuta o insorgenza insidiosa
→ I sintomi non sono alleviati dalla fisioterapia o c'è un peggioramento
→ Il paziente ha perso o preso più del 10% del suo peso corporeo in 3 settimane
→ Presentazione progressiva o ciclica dei sintomi (peggio/meglio/peggio)
→ Il paziente non trova sollievo a riposo o in nessun cambio di posizione
→ I sintomi sono sproporzionati rispetto alla lesione
→ Sintomi bilaterali (edema, formicolio o torpore, variazioni del colore della pelle, pulsazioni, variazioni del letto ungueale, rash cutanei)
→ Una massa che cresce è sempre un tumore fino a prova contraria
→ Un ematoma deve sempre ridursi e non aumentare

Le bandiere rosse

PRESENTAZIONE DEL DOLORE

→ Dolori diffusi alla schiena e alla spalla
→ E' presente dolore senza limitazione al movimento
→ Dolore notturno costante e intenso
→ Dolore descritto come «pulsazione», «coltellata» o «profondo»
→ Dolore diffuso, difficilmente localizzabile
→ Variazione del dolore dopo aver assunto farmaci o cibo

Le bandiere rosse

SEGNI E SINTOMI ASSOCIATI

→ Recente episodio di confusione (neurologico o infettivo)

→ Presenza di sintomi costituzionali (febbre, diaforesi diurna o notturna, nausea, vomito, diarrea, pallore, gìramenti di testa, affaticabilità, perdita di peso)

→ Dolori articolari associati a rash cutanei o noduli (reumatologico)

→ Ciclo mestruale con presentazione insolita e sintomi associati

Un altro caso

Donna di 42 anni, era in bicicletta quando è stata tamponata e sbalzata a terra. E' stata visitata al Pronto Soccorso del paese più vicino dove le hanno fatto una lastra al cranio e al collo senza evidenti lesioni. E' stata dimessa con una prescrizione per antidolorifici e miorilassanti.

Si presenta tre giorni dopo nel tuo Studio lamentando dolori alla spalla sinistra, alle coste e al polso sinistro. E' presente un livido scuro ed esteso lungo il torace e l'addome superiore, soprattutto a sinistra. Nessun altro sintomo riferito.

Alla valutazione risulta: range di movimento della spalla libero ma dolorante su tutti i piani; dolore alla palpazione delle coste 9, 10 e 11 ma senza deformità; screening neurologico negativo.

Il programma

Un programma intensivo di fisioterapia che comprende:

→ Tre trattamenti a settimana
→ Esercizi pendolari per la spalla e pompage
→ Mobilizzazione passiva e attiva assistita della spalla su tutti i piani
→ Rinforzo con elastici
→ Stretching

Evoluzione

→ Dopo la seconda seduta, la paziente riferisce un forte spasmo alla zona dei paravertebrali cervicali.
→ Dopo la prima settimana di terapia, la paziente chiama il Terapista per influenza e vomito.
→ Una volta ritornata, la paziente riprende con la regolare fisioterapia: riferisce che il dolore alla spalla e alla schiena è rimasto uguale, ma che si sente meglio e meno rigida.

→ Tre settimane dopo l'incidente, la paziente ha un collasso mentre sta lavorando e viene portata in ospedale dove viene operata d'urgenza.

→ CHE COSA E' SUCCESSO?

Finale

L'incidente aveva causato una lesione della milza con un lento sanguinamento all'interno della parete addominale. La lesione si era poi allargata con la ripresa delle normali attività della vita quotidiana, portando ad emorragia grave.

→ ***QUALI SONO STATI GLI ERRORI DEL FISIOTERAPISTA?***

Gli errori

- → La paziente è venuta spontaneamente dopo un incidente e non su prescrizione, un motivo in più per prestare attenzione
- → Non c'è mai stato un contatto con alcun Medico per tutta la durata del trattamento, nonostante alcuni segni evidenti come i vasti ematomi sul corpo
- → Il dolore alla spalla senza limitazioni di movimento dopo un trauma può essere segno di sanguinamento nel peritoneo (Segno di Kehr → è già una bandiera rossa da solo!!!)
- → L'improvvisa insorgenza di segni costituzionali: la febbre, il vomito e lo spasmo ai mm. cervicali dovevano essere considerati seriamente anche se la paziente li collegava all'influenza

Il ragionamento etico

Il fisioterapista deve sempre svolgere un ragionamento etico, cioè quel ragionamento che si muove tra:

- *RESPONSABILITA': verso i pazienti per le spiegazioni e i trattamenti e verso i colleghi per la crescita professionale*

- *APPROPRIATEZZA: intesa come capacità di intervenire in modo efficace sfruttando al meglio le risorse disponibili.*

E tenendo a mente il CODICE DEONTOLOGICO, che deve essere un vero e proprio patto con la società: non si deve riflettere sull'agenda del che cosa fare, ma su ***CHI SIAMO CHIAMATI AD ESSERE COME PROFESSIONISTI****.*